

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	小兒密閉式胸腔引流術評核表	編號	A31000-Q06-F-D12
	制定 單位	護理部	版本	第 2.6 版
			修正日期	110 年 12 月 13 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員。

二、評核方式：請受試者以口述或實際操作。

三、評核內容：

- 核對醫囑及辨識病人（至少二種以上方法），並向病童或家屬解釋小兒密閉式胸腔引流術之目的及填寫同意書。
- 洗手。
- 以無菌技術方式倒入無菌蒸餾水(300ml)於胸腔引流瓶內，使長管埋於水下 2-3 公分後，蓋緊引流瓶蓋。
- 在引流瓶上貼一橫條膠布，並註明日期、時間、水量：300c.c. D/W。
- 協助病童適當擺位並作適宜的約束。
- 依醫囑適當的給予鎮靜劑密切觀察病童生命徵象。
- 協助醫師以 2%Tr. Idoine 及 75%Alcohol 三次消毒穿刺部位後以無菌技術遞無菌手術衣、無菌手套、治巾、小眼洞巾、刀片、胸管、針線(3.0 Dermalon)、靜切包給醫師。
- 協助醫師插入胸管後用縫線將胸管固定在皮膚上。
- 請醫師先取小眼洞巾後以無菌技術遞胸腔引流管給醫師。
- 護理人員以無菌技術將引流管與引流瓶接好以寬膠布固定，並檢查各連接處是否固定、套牢、緊密。
- 胸腔引流瓶接上外科接管及 Emberson，Emberson 刻度依醫囑使用。
- 以 0.9% N/S、B-Iodine CD 後以 Y 紗固定胸管，再以無菌紗布覆蓋 Mifex 固定之。
- 病床旁應備有止血鉗，固定胸管及作為緊急狀況時使用。
- 觀察及記錄引流液之性質、顏色、量引流速度及黏稠度，胸管穿刺放置時間及生命徵象、病童反應(如：呼吸急促、發紺、皮下氣腫)等。
- 整理單位，清洗用物歸位後洗手。
- 觀察及記錄病童有無不良反應，如：呼吸喘、眩暈、穿刺部位出血、氣胸、皮下氣腫、膿性感染；若突然引流過多液體可能會造成縱膈腔突然移位，甚至壓迫心臟而死亡。
- 追蹤 chest X-ray 確定胸管留置部位並觀察有無合併症產生。
- 利用擠壓法或使用滾輪鉗 Milking，保持引流管暢通。

